·共识与指南·

实体器官移植受者新型冠状病毒感染诊疗专家共识(2023 年版)

国家传染病医学中心　中华医学会器官移植学分会　中国康复医学会器官移植康复专业委员会　中国器官移植发展基金会器官移植受者健康管理专项基金

通信作者:王正昕,复旦大学附属华山医院普外科　复旦大学器官移植研究所,上海　200040,Email:wangzhengxin@huashan.org.cn;郑建铭,复旦大学附属华山医院感染科,上海　200040,Email:zhengjianming@fudan.edu.cn;陈静瑜,无锡市人民医院胸外科,无锡　214000,Email:chenjy@wuxiph.com;郑哲,中国医学科学院阜外医院心血管外科,北京　100037,Email:zhengzhe@fuwai.com;霍枫,中国器官移植发展基金会器官移植受者健康管理专项基金管理委员会,北京　100010,Email:gzhuofeng@163.com

【摘要】 虽然目前新型冠状病毒变异株的致病性和毒力已较原始株有所下降,大多数患者预后良好,但实体器官移植(SOT)受者为新型冠状病毒感染脆弱人群,即使全程接种新型冠状病毒疫苗,SOT 受者感染后的住院或死亡风险依然较高。SOT 受者感染新型冠状病毒后的临床表现、诊断和治疗均较普通人群存在很大的特殊性,需要高度关注。目前尚缺乏针对 SOT 受者可供参考的新型冠状病毒感染诊疗相关指南或共识。因此,参考《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》及国内外文献,编写团队撰写了《实体器官移植受者新型冠状病毒感染诊疗专家共识(2023 年版)》。本共识基于国内外新型冠状病毒感染的循证医学证据,并经过专家多次研讨达成一致意见后撰写成文,形成 21 条推荐意见,为 SOT 受者新型冠状病毒感染的诊疗提供参考。

【关键词】 实体器官移植;新型冠状病毒;诊断;治疗

基金项目:上海申康医院发展中心临床三年行动计划(SHDC2020CR2021B);国家自然科学基金(82241225);上海市市级科技重大专项(HS2021SHZX001)

DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20230210-00038　　**中图分类号**:R512.99

Expert consensus on the management of coronavirus disease 2019 in solid organ transplant recipients (2023 edition)

National Center for Infectious Diseases; Chinese Society of Organ Transplantation, Chinese Medical Association; Organ Transplantation Rehabilitation Committee of the China Society of Rehabilitation Medicine; Special Fund for Health Management of Organ Transplant Recipients of the China Organ Transplantation Development Foundation

Corresponding authors: Wang Zhengxin, Department of General Surgery, Huashan Hospital, Fudan University, Institute of Organ Transplantation, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: wangzhengxin@huashan.org.cn; Zheng Jianming, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhengjianming@fudan.edu.cn; Chen Jingyu, Department of Thoracic Surgery, Wuxi People's Hospital, Wuxi 214000, China, Email: chenjy@wuxiph.com; Zheng Zhe, Department of Cardiovascular Surgery, Fu Wai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100037, China, Email: zhengzhe@fuwai.com; Huo Feng, Special Fund Management Committee of Organ Transplant Recipients Health Management, China Organ Transplantation Development Foundation, Beijing 100010, China, Email: gzhuofeng@163.com

新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2;以下简称“新冠病毒”)感染大流行已席卷全球。虽然目前的新冠病毒变异株的致病性和毒力已较原始株有所下降,大多数患者预后良好,但老年人、有慢性基础疾病者、围生期及妊娠患者、肿瘤患者、肥胖人群等,感染后病死率高于一般人群。其中,实体器官移植(solid organ transplant,SOT)受者为新冠病毒感染脆弱人群,即

使全程接种新冠病毒疫苗，SOT 受者感染新冠病毒的住院或死亡风险依然较高。SOT 受者感染新冠病毒后的临床表现、诊断、治疗与普通人群相比均存在很大的特殊性，需要高度关注。自 2017 年以来，我国器官捐献与移植数量位居亚洲第一、世界第二，每年有近 1 万例肾移植手术、6 000 余例肝移植手术、700 余例心脏移植手术和 700 余例肺移植手术。目前尚缺乏针对如此庞大的 SOT 受者人群可供参考的新冠病毒感染诊疗领域的指南或共识。因此，国家传染病医学中心、中华医学会器官移植学分会、中国康复医学会器官移植康复专业委员会和中国器官移植发展基金会器官移植受者健康管理专项基金管理委员会组织国内感染病学、呼吸与危重症医学、器官移植学、临床药学等领域专家，通过检索国内外相关文献，撰写了《实体器官移植受者新型冠状病毒感染诊疗专家共识（2023 年版）》（以下简称“共识”）。本共识基于国内外新冠病毒感染的循证医学证据，并经过专家多次研讨后撰写完成，供同道参考借鉴。

一、共识的制订过程

本共识的制订方法和流程主要基于 2014 年 WHO 发布的《WHO 指南制订手册》[1] 和 2016 年中华医学会发布的《制订/修订 < 临床诊疗指南 > 的基本方法及程序》[2]，并依据指南研究与评价工具（appraisal of guidelines research and evaluation, AGREE Ⅱ）[3] 和卫生保健实践指南的报告条目（reporting items for practice guidelines in healthcare, RIGHT）[4] 的具体要求进行制订和报告。

1. 共识制订工作组的组建：本工作组包括指导委员会、秘书组、证据评价组、共识专家组和外审组。指导委员会职责为成立工作组，确定共识范围，监督共识制订过程和审定共识全文；秘书组职责为组织推荐意见共识会议和初稿外审，整理专家意见和撰写共识初稿；证据评价组进行证据总结和分级，提供必要的其他方法学支持；共识专家组由感染病学、器官移植学和临床药学等多学科专家构成，负责提出临床问题、推荐意见的制订，以及共识文件的审定；外审组由不参与共识制订的相关学科专家构成，职责为对初稿进行阅读并反馈意见。

2. 利益冲突声明与管理：本共识工作组全体成员声明无近 3 年相关的经济利益冲突与学术利益冲突。收集汇总后经秘书组讨论判定，若专家成员声明的利益关系对共识内容构成利益冲突，则根据其严重程度进行管理。

3. 共识使用者与目标人群：本共识供各级医疗机构中感染病学、器官移植学和临床药学等多学科相关的专业人员参考使用。推荐意见的目标人群为存在感染新冠病毒风险的 SOT 受者。

4. 共识范围及优先临床问题的确定：通过共识专家会议对临床关注的问题进行讨论，最终选择出本共识拟解决的 21 个临床问题，涉及 SOT 和新冠病毒感染两大方面。

5. 证据检索与筛选：证据评价组按照人群、干预、对照、结局（population, intervention, comparison, outcome, PICO）的原则对纳入的临床问题进行解构和检索，检索 MEDLINE（PubMed）、The Cochrane Library、中国生物医学文献服务系统、万方知识数据服务平台和中国知网数据库（CNKI），纳入指南、共识、系统评价和荟萃分析、随机对照试验（randomized controlled trial, RCT）、非 RCT 队列研究和病例对照研究等类型的证据。检索词包括：“新型冠状病毒”“实体器官移植”“诊断”“检测”“治疗”“预防”。所有类型文献的检索时间均为 2020 年 1 月至 2023 年 1 月，发表语言限定为中文或英文。

6. 文献筛选：完成证据检索后，每个临床问题均由 2 名证据评价组成员按照题目、摘要和全文的顺序逐级独立筛选文献，确定纳入符合具体临床问题的文献，完成筛选后 2 人进行核对，如存在分歧，则通过共同讨论或咨询第三方协商确定。

7. 证据分级和推荐强度分级：使用 2009 版牛津大学循证医学中心的证据分级与推荐强度标准对每个临床问题的证据质量和推荐强度进行分级（表 1）[5]。

表 1　2009 版牛津大学证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据分级	治疗或危害
A	1a	随机对照试验的系统评价
	1b	结果可信区间小的随机对照试验
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究（包括低质量的随机对照试验，如失访率 > 20% 者）
	2c	基于患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见（即无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测）

注：对于因以下任一原因导致无法得出确定性结论的证据，使用者可以在证据级别后加上“-”，这类证据不具有确定性，只能获得 D 级推荐，包括单个结果具有较宽的可信区间或一个存在很大异质性的系统评价

8. 推荐意见的形成：共识专家组基于证据评价组提供的证据，同时考虑推荐意见的利弊、干预措施成本和专家的个人经验后形成了 21 条推荐意见。

同时秘书组和证据评价组基于专家提出的反馈建议对推荐意见和支持证据进行修改完善。

9. 共识的撰写与外审：推荐意见达成共识后，工作组参考国际指南的报告规范 RIGHT 完成初稿的撰写[4]，并提交外审组专家进行审阅，根据反馈意见对初稿进行修改，最终形成共识终稿。

二、SOT 受者新冠病毒感染的流行病学和临床特点

1. SOT 受者感染新冠病毒的潜伏期和传染性时间特点

推荐意见 1：SOT 受者对新冠病毒普遍易感。目前没有证据证明 SOT 受者感染新冠病毒的潜伏期与其他新冠病毒感染者有差异。SOT 受者感染新冠病毒，在潜伏期即具有传染性，由于 SOT 受者感染新冠病毒的排毒期更长，其具有传染性的时间更长。（推荐强度 B，证据等级 2a）

SOT 受者感染新冠病毒的潜伏期为 1～14 d，大部分为 3～7 d，且潜伏期即具有传染性。目前没有证据支持移植患者的潜伏期与其他新冠病毒感染者存在差异[6]。Fraser 等[7]总结 15 篇文献的 223 例肝移植新冠病毒感染患者，发现这些患者一般感染新冠病毒后 7 d 内出现症状。年龄≥60 周岁或者免疫抑制的 SOT 受者的感染风险增大[8]。通常，奥密克戎变异株感染者的排毒期中位时间为 11.3 d，而 SOT 受者排毒期则延长至 14 d，更长的排毒期意味着其具有传染性的时间可能更长[9]。

2. SOT 受者感染新冠病毒的临床表现特点

推荐意见 2：SOT 受者感染新冠病毒的症状与普通人群相似，主要临床表现为发热、乏力和肌痛，还有一些患者表现为咽痛、咳嗽、呼吸短促、腹泻、头晕头痛、失嗅症和厌食等。需警惕 SOT 受者因使用免疫抑制剂导致早期症状隐匿而后期病情进展较快。尤其需要警惕 SOT 受者腹泻导致免疫抑制剂药物浓度的变化，需要密切监测血药浓度。（推荐强度 B，证据等级 2a）

SOT 受者感染新冠病毒的症状表现为发热、乏力和肌痛，还有一些患者表现为咽痛、咳嗽、呼吸短促、腹泻、头晕头痛、失嗅症和厌食等[10]。SOT 受者在新冠病毒感染初期，呼吸道症状（如呼吸困难）相较于发热更加常见。若出现腹泻，需警惕免疫抑制剂的药物浓度和相应免疫状态的变化。SOT 受者因使用免疫抑制剂导致早期症状隐匿而后期病情进展较快，如 SOT 受者住院期间肺炎发生率、转入 ICU 的比例及病死率均较其他新冠病毒感染者增加[11]。在肾移植住院受者中，继发急性肾损伤和呼吸困难的风险较正常人分别高 3.78 倍和 4.53 倍，且提示预后不佳[12]。Kulkarni 等[13]汇总 2019 年 12 月至 2021 年 5 月 18 篇有关肝移植受者感染新冠病毒的文献，发现肝移植受者感染新冠病毒后继发急性肾损伤的发生率为 33.22%，血栓发生率为 5.75%，细菌感染发生率为 11.6%，真菌感染发生率为 2.58%。年龄是 SOT 受者感染新冠病毒预后的独立危险因素，年龄≥60 周岁的 SOT 受者感染新冠病毒后的病死率风险是正常人群的 4.8 倍[14]。Bartelt 和 van Duin[15]则认为相较于器官移植类型、维持性免疫抑制方案和移植后时间等移植特异性相关因素，年龄和潜在合并症是决定 SOT 受者感染新冠病毒后疾病严重程度更重要的因素。

3. SOT 受者感染新冠病毒是否增加其重症率和病死率？

推荐意见 3：SOT 受者感染新冠病毒后，相较于普通人群，其重型/危重型发生率和病死率更高。高龄和基础合并症多的 SOT 受者新冠病毒感染的预后可能更差。（推荐强度 B，证据等级 2a）

在早期的报道中，SOT 受者新冠病毒感染的死亡风险很高[7,16-18]。根据西班牙早期的数据（截至 2019 年 12 月），肾移植术后 60 d 内发生新冠病毒感染的患者中有 46% 死亡[16]。截至 2021 年 1 月，多项综述提示：在肾移植术后新冠病毒感染患者中，呼吸困难、急性肾损伤、急性心肌梗死等严重并发症的发生率，以及重型率和病死率均显著高于普通人群[16-17,19]。一项系统综述纳入的 15 项研究中共有 223 例肝移植受者发生新冠病毒感染，其疾病重症化或需要住院的比例非常高，重症率为 36%，病死率为 19.3%，均显著高于普通人群[7]。心脏移植受者发生新冠病毒感染表现出与普通人群相似的人口统计学和临床特征，但其预后明显更差[20-21]。同时，多项关于 SOT 受者感染新冠病毒的荟萃分析显示其重症率及病死率显著高于普通人群[10,18,20]。

4. 二次感染新冠病毒是否会增加 SOT 受者的病死率？

推荐意见 4：SOT 受者二次感染新冠病毒的风险较高，仍需要加强防护。（推荐强度 B，证据等级 2b）

二次感染是指感染 1 次新冠病毒后，身体已完全康复，但又发生了第 2 次新冠病毒感染，往往是由于新冠病毒变异导致突破感染。目前不同国家或地区针对二次感染的定义尚未完全统一，但都指出要与首次感染间隔一段时间，美国定义的时间间隔为 60～90 d，英国则是≥90 d，且还需要结合临床表

现、核酸或抗原检测等综合判定。

美国一项研究跟踪了 5 919 例 SOT 受者，在 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 30 日首次感染新冠病毒的患者二次感染的发病密度为 9.4/10 万人天[22]，高于意大利一项关于普通人群二次感染的回顾性研究(1.0/10 万人天)[23]，且其中 2 例 SOT 受者在二次感染前几周的免疫评估显示他们在二次感染前均有病毒特异性 $CD4^+$ T 淋巴细胞应答和免疫球蛋白(immunoglobulin，Ig) G 检测阳性，这表明既往感染新冠病毒的 SOT 受者即使在产生细胞和体液免疫反应后，随着抗体的衰减，二次感染的风险仍然很高。

塞尔维亚的 13 792 例二次感染患者的数据显示，99.17% 二次感染的患者症状都比较轻微，二次感染人群中的病死率为 0.15%[24]；而美国的一项研究显示，9 119 例新冠病毒感染者中只有 2 例患者的死亡与二次感染相关[25]。目前暂未见关于 SOT 受者二次感染新冠病毒后的重症率及病死率的相关研究报道。

三、SOT 受者新冠病毒感染的诊断和治疗

1. SOT 受者新冠病毒核酸或抗原的检测时机

推荐意见 5：SOT 受者如果有流行病学史，且出现发热等与新冠病毒感染一致的症状，应立即进行新冠病毒核酸或抗原检测。在病程最初 5～7 d 内检测的阳性率较高。在确诊 6 d 后，可定期检测新冠病毒核酸或抗原(2 次采样至少间隔 24 h)以评估患者新冠病毒是否转阴。(推荐强度 B，证据等级 2a)

作为高危人群，SOT 受者应重视新冠病毒感染的相关检测。如果存在流行病学史，且出现发热等与新冠病毒感染一致的症状，应立即进行新冠病毒核酸或抗原检测[26]。在病程最初 5～7 d 内检测的阳性率较高[27]。此外，在确诊 6 d 后，可定期检测新冠病毒核酸或抗原(2 次采样至少间隔 24 h)以评估患者新冠病毒是否转阴[28]。

核酸检测可采用呼吸道标本(鼻咽拭子、咽拭子、痰、气管抽取物)或其他标本。呼吸道分泌物的成分可能有很大差异，取样工作的标准性也可能有所不同，这偶尔会导致假阴性的检测结果。对于高度怀疑新冠病毒感染且上呼吸道拭子检测阴性的患者，可在下呼吸道分泌物(如痰液或支气管肺泡灌洗液)中进行新冠病毒核酸检测[29]。

新冠病毒特异性 IgM 抗体、IgG 抗体在发病 1 周内阳性率均较低。恢复期 IgG 抗体水平较急性期升高 4 倍或以上有回顾性诊断意义。因此，新冠病毒抗体检测用于诊断的时效性不如新冠病毒抗原及核酸检测。SOT 受者由于长期服用免疫抑制剂，其产生的抗体效价较普通人群低，而且感染新冠病毒后病情进展较快，因此不推荐新冠病毒抗体检测用于 SOT 受者新冠病毒感染的诊断。

2. SOT 受者感染后发生重型或危重型的预警指标

推荐意见 6：低氧血症进行性加重，外周血淋巴细胞进行性减少，炎症生物标志物和细胞因子水平升高，D-二聚体等凝血功能相关指标持续异常，乳酸脱氢酶、AST、ALT、肌酸激酶、高敏肌钙蛋白等指标明显升高，胸部影像学检查显示肺部病变明显进展，以及移植物功能不全是 SOT 受者感染新冠病毒后发生重型或危重型的重要预警指标。(推荐强度 B，证据等级 2a)

从中型进展至重型或危重型的病例，其外周血白细胞、中性粒细胞和中性粒细胞与淋巴细胞比值增加；相反，则出现外周血淋巴细胞逐渐减少，但过度激活。乳酸脱氢酶、AST、ALT、肌酸激酶、高敏肌钙蛋白 I、脑钠肽、肌酐和尿素水平逐渐增加，D-二聚体升高是疾病重症化的重要指标之一，也是死亡的独立危险因素。另外，低白蛋白血症是疾病严重程度的非特异性标志物，与新冠病毒感染预后较差有关[30]。

新冠病毒感染重症化常伴随炎症反应活化，因此许多炎症因子(如 CRP、血清淀粉样蛋白 A、铁蛋白、IL-6 和 TNF-α)等在有重症化倾向的病例中常升高[31]。有研究提示 CRP 与白蛋白比值可作为区分重型和非重型新冠病毒感染的指标[32]。

在一项回顾性研究中，年龄≥63 岁、淋巴细胞绝对值≤1.02×10^9/L、CRP≥65.08 mg/L 的患者新冠病毒感染重症化的风险较高[33]。肺部 CT 上新冠病毒感染面积的比例与外周血淋巴细胞百分比和淋巴细胞计数呈负相关，但与中性粒细胞百分比呈正相关[34-35]。

移植物功能不全通常是 SOT 受者感染新冠病毒后发生重型或危重型的重要预警指标。其中，肝脏移植物功能不全通常表现为碱性磷酸酶和 γ-GT 升高，随后是进行性高胆红素血症[36]。梅奥医学中心将肝移植早期同种异体移植物功能障碍定义为存在以下 1 项或多项：① 术后第 7 天总胆红素≥10 mg/dL；② 术后第 7 天 INR≥1.6；③ 术后的前 7 d 内 ALT 或 AST≥2 000 U/mL[37]。肌酐升高、移植前使用胺碘酮、需要机械通气支持，以及较长的缺血时间与心脏移植物功能不全相关。需要吸入氧浓度＞50% 与肺移植物功能不全相关，可结合 X 线等胸部

影像学检查表现对移植物功能不全进行判定[38-39]。

在 SOT 受者中，需对老年人和伴有基础疾病（心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病、高血压、肥胖症和癌症）的新冠病毒感染重型高危患者进行动态监测，有助于对疾病严重程度进行预警[31,38]。

3. SOT 受者合并或继发感染的风险是否增高？

推荐意见 7：SOT 受者在感染新冠病毒后，合并或继发细菌和（或）真菌感染的风险增高，应尽早进行相关实验室检测、留取标本培养及完善胸部影像学检查。（推荐强度 B，证据等级 2b）

普通人群感染新冠病毒后局部呼吸道黏膜损伤，加之免疫系统紊乱、使用糖皮质激素、气管插管等因素，随着住院时间的延长，很容易继发细菌和（或）真菌感染[40]。而 SOT 受者因长期服用免疫抑制剂，合并细菌和（或）真菌感染的风险更高。在感染新冠病毒的后期（病程≥2 周以上），若患者仍出现反复发热、咳嗽且伴有较多痰液，要警惕合并或继发细菌和（或）真菌感染可能，建议尽早进行相关实验室检测、留取标本检测和培养，以及完善胸部影像学检查。

一些实验室指标如外周血白细胞计数、CRP 等对感染有一定提示作用，但新冠病毒感染诱发的炎症也会导致 IL-6、CRP 和铁蛋白等炎症标志物持续升高数周，这使合并或继发细菌和（或）真菌感染的诊断复杂化[41]。奥地利的一项前瞻性单中心研究纳入了 66 例入住 ICU 进行体外膜氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）评估的新冠病毒感染患者，测定的多种实验室参数中，IL-10 诊断继发感染的受试者操作特征曲线下面积为 0.84，而包括 CRP、IL-6、降钙素原和 IL-10 在内的多变量逐步回归模型诊断继发感染的受试者操作特征曲线下面积为 0.93，后者的测试性能更佳[42]。这项研究强调了 IL-10 单独或联合 CRP、IL-6 和降钙素原用来诊断合并或继发感染与新冠病毒感染重型或危重型患者的重要性[42]。

留取的标本除了送相应的涂片和培养等病原学检查外，还可以进行 β-D-葡聚糖试验、曲霉半乳甘露聚糖抗原试验、隐球菌荚膜多糖抗原检测等抗原检测，结核感染 T 淋巴细胞检测等免疫学检测，以及多重 PCR、宏基因组学二代测序等分子生物学检测。对于常规标本（痰或血）培养阴性的患者，必要时可行肺泡灌洗液病原学培养。明确合并或继发感染的病原体，减少广谱抗菌药物的使用有助于减少耐药菌感染的发生。

4. SOT 受者感染新冠病毒后不同临床分型的治疗方案

推荐意见 8：对于 SOT 受者，一旦出现新冠病毒感染的症状，应尽早在专科医师指导下明确诊断、评估各项生命体征和高危预警实验室指标，并完善胸部影像学检查，综合患者病情调整免疫抑制剂的剂量，符合抗新冠病毒治疗条件的患者应尽早使用抗新冠病毒药物。对于中型、重型或危重型患者，建议住院治疗，在制订 SOT 受者感染新冠病毒后的治疗方案时，要注意抗新冠病毒药物与免疫抑制剂的相互作用。（推荐强度 B，证据等级 2b）

《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》将免疫功能缺陷（长期使用皮质类固醇或其他免疫抑制剂导致免疫功能减退状态）患者列为重型或危重型高危人群，SOT 受者长期服用免疫抑制剂，其免疫系统处于抑制状态，应注重其感染新冠病毒后的健康管理[26]。在新冠病毒检测呈阳性的 SOT 受者中，死亡的危险因素包括高龄、肥胖、心血管或呼吸系统合并症和某些实验室指标异常（包括淋巴细胞计数、血小板计数减少，铁蛋白、CRP、肌钙蛋白、D-二聚体升高等）[43]。故对于 SOT 受者而言，一旦出现新冠病毒感染的症状，应尽早在专科医师指导下明确诊断，评估各项生命体征和高危预警实验室指标，并完善胸部影像学检查，综合患者病情调整免疫抑制剂剂量，符合抗新冠病毒治疗条件的患者应尽早使用抗新冠病毒药物，从而降低患者进展为重型或危重型的风险。对于中型、重型或危重型患者，由于病情可能进展迅速，建议住院治疗。针对普通人群新冠病毒感染后的治疗方案，目前国内外已经发布多项指南和专家共识，SOT 受者的治疗可作部分参考，但要注意抗新冠病毒药物与免疫抑制剂的相互作用[44-45]。

5. SOT 受者如何选择抗新冠病毒药物

推荐意见 9：SOT 是轻型和中型新冠病毒感染患者进展为重型或危重型的高风险因素之一，应结合患者病程、病情及基础用药情况，尽早合理地选用抗新冠病毒药物，抑制病毒复制并控制病毒感染进程。（推荐强度 A，证据等级 1a）

对于重型和危重型患者，若新冠病毒核酸阳性[循环阈值（cycle threshold value，Ct 值）≤30]，亦建议使用抗病毒药物治疗。（推荐强度 D，证据等级 5）

目前可及的抗新冠病毒小分子药物有奈玛特韦/利托那韦（paxlovid）、阿兹夫定、莫诺拉韦、氢溴酸氘瑞米德韦（vv116）和先诺特韦/利托那韦。

奈玛特韦/利托那韦组合包装适用人群为发病

5 d 内的轻、中型且伴有进展为重型高风险因素的成年患者。用法：奈玛特韦 300 mg 与利托那韦 100 mg 同时服用，每 12 h 1 次，连续服用 5 d。使用前应详细阅读说明书，不得与哌替啶、雷诺嗪等高度依赖细胞色素 P450（cytochrome P450，CYP）3A 进行清除且其血浆浓度升高会导致严重和（或）危及生命的不良反应的药物联用。不建议在哺乳期使用。中度肾损伤者应将奈玛特韦减半服用，重度肝、肾损伤者不应使用。环孢素、他克莫司与利托那韦具有显著的药物相互作用，需调整剂量[46]。

阿兹夫定用于治疗中型新冠病毒感染的成年患者。用法：空腹整片吞服，每次 5 mg，每日 1 次，疗程至多不超过 14 d。使用前应详细阅读说明书，注意与其他药物的相互作用、不良反应等问题。不建议在妊娠期和哺乳期使用，中重度肝、肾损伤患者慎用。既往研究报道，阿兹夫定首次给药后第 7 天临床病情改善的受试者比例明显增高，受试者临床状态改善的中位时间明显缩短约 3 d[47]。

莫诺拉韦适用人群为发病 5 d 内的轻、中型且伴有进展为重型高风险因素的成年患者。用法：每次 800 mg，每 12 h 口服 1 次，连续服用 5 d。不建议在妊娠期和哺乳期使用。既往研究显示，相较安慰剂组，症状出现 5 d 内使用莫诺拉韦的新冠病毒感染患者相关住院或死亡风险显著降低 31%，60 岁以上患者因任何原因住院或死亡风险显著降低 19%。此外，莫诺拉韦相对于其他推荐的抗病毒药物的效果差，因此其非普通人群的一线推荐用药，但是该药与 SOT 受者使用的免疫抑制剂无明显相互作用，在 SOT 受者中使用有一定的优势[48]。

氢溴酸氘瑞米德韦适用人群为轻、中型新冠病毒感染的成年患者。用法：推荐连续口服 10 次，每 12 h 1 次，共 5 d；第 1 天，每次 600 mg（100 mg/片，6 片），每 12 h 1 次，服用 2 次；第 2 ~ 5 天，每次 300 mg（100 mg/片，3 片），每 12 h 1 次，连续服用 8 次。在有轻、中型症状的 SOT 受者中，就临床恢复时间而言，相比于奈玛特韦/利托那韦，氢溴酸氘瑞米德韦的非劣效性已被证实，而且使用氢溴酸氘瑞米德韦的不良事件发生率低于奈玛特韦/利托那韦组（67.4% 比 77.3%）[49]。

先诺特韦/利托那韦适用人群为轻、中型新冠病毒感染成年患者。用法：先诺特韦 0.750 g（0.375 g/片，2 片）联用利托那韦 0.1 g（0.1 g/片，1 片），每 12 h 口服 1 次，连续服用 5 d。目前无具体的证据支持该药与其他药物的相互作用。先诺特韦是 P-糖蛋白（P-glycoprotein）、CYP3A 的底物，其作用机制与奈玛特韦相似，可以参考奈玛特韦/利托那韦的药物相互作用及剂量调整方案。

6. SOT 受者新冠病毒持续阳性时，是否延长抗病毒药物的治疗时间？

推荐意见 10：SOT 受者易出现新冠病毒核酸持续阳性（Ct 值≤30），在评估获益风险比后，可适当延长小分子药物抗病毒疗程。在病情治疗需要的情况下，可以尝试换用或者联用其他不同作用机制的抗病毒药物治疗。（推荐强度 D，证据等级 5）

因持续服用免疫抑制剂，一些 SOT 受者尽管接受过抗病毒治疗，患者仍可出现持续数周甚至数月的新冠病毒核酸检测阳性结果，但是并非所有具有上述表现的患者都需要再次接受抗病毒治疗。当核酸检测的 Ct 值 > 30 时，表示检测到较少量残留的病毒基因，病毒进一步复制或传播的可能性较低，因此仅建议当 Ct 值≤30 时，才具备进一步继续抗病毒治疗的价值。然而如何进行下一步抗病毒治疗的方案仍未有明确的研究结果，结合病例报道及专家临床治疗经验，建议可以适当延长原有的小分子抗病毒药物治疗[50-52]。此外，也可以根据病情治疗的需要，尝试换用或者联用其他不同作用机制的抗病毒药物治疗。

7. SOT 受者如何进行新冠病毒感染炎症反应的免疫治疗

推荐意见 11：SOT 受者感染新冠病毒发生炎症反应的免疫治疗总体可参考普通人群诊疗指南。（推荐强度 D，证据等级 5）

在新冠病毒感染发生炎症反应的免疫治疗策略上，SOT 受者与普通人群的差异尚缺乏研究报告，因此，建议目前参考普通人群的诊疗指南进行治疗，同时应特别注意是否存在相关禁忌证。具体来说，使用巴瑞替尼需注意：① 在活动性、慢性或复发性感染的患者中，使用巴瑞替尼治疗前应该谨慎考虑风险和获益，如果出现感染，应该密切监测患者，而且如果患者对标准治疗无应答，则应该暂停巴瑞替尼治疗，并在感染痊愈前不得重新开始巴瑞替尼治疗；② 巴瑞替尼不应该用于有活动性结核的患者，在未接受治疗的结核潜伏感染患者中，开始巴瑞替尼治疗之前应考虑进行抗结核治疗；③ 在患者常规治疗期间，观察到中性粒细胞计数 $< 1 \times 10^9$/L、淋巴细胞计数 $< 0.5 \times 10^9$/L 或血红蛋白 < 80 g/L 时，不应起始治疗，或应该暂停治疗；④ 如果患者发生了带状疱疹，则应该暂时停止巴瑞替尼治疗，直至症状痊愈；⑤ 巴瑞替尼开始治疗之前应该依据临床指南进行病毒性肝炎筛查，具有 HBV 或 HCV 活动性感染

证据的患者应被排除在外，HCV 抗体阳性但是 HCV RNA 阴性的患者可允许使用，抗-HBs 和抗-HBc 阳性但是 HBsAg 阴性的患者也允许使用；⑥ 如果患者常规治疗期间观察到 ALT 或 AST 升高，以及出现疑似药物导致的肝损伤，则应该暂停巴瑞替尼治疗，直至排除该诊断；⑦ 存在深静脉血栓或肺栓塞风险因素的患者，如高龄、肥胖、有深静脉血栓或肺栓塞病史、手术或卧床，应慎用巴瑞替尼，如果出现深静脉血栓或肺栓塞的临床特征，应暂停巴瑞替尼治疗，立即对患者进行评估，并给予适当治疗；⑧ 不推荐与生物类改善病情抗风湿药或其他 Janus 激酶抑制剂联合用药，原因是无法排除增加免疫抑制的风险。有关巴瑞替尼与强效免疫抑制剂联合使用的数据（例如硫唑嘌呤、他克莫司、环孢素）有限，当与这些药物联合使用时应该谨慎[53]。

使用托珠单抗需注意：① 感染（包括严重感染）。目前已有报道，接受免疫抑制剂（包括托珠单抗）治疗类风湿关节炎的患者发生了细菌、分枝杆菌、侵袭性真菌、病毒、原虫或其他机会性病原体引起的严重感染，甚至致死性感染。最常见的严重感染包括肺炎、尿路感染、蜂窝织炎、带状疱疹、胃肠炎、憩室炎、脓毒症和细菌性关节炎。使用托珠单抗治疗发生的机会性感染包括结核分枝杆菌、隐球菌、曲霉、假丝酵母菌和肺孢子菌感染。临床试验中未报告的其他严重感染也可能发生（如组织胞浆菌、球孢子菌、李斯特菌感染）。通常患者会表现为播散性感染而非局灶感染。② 托珠单抗用于除患有全身型幼年型特发性关节炎以外疾病患儿的疗效和安全性尚未确定。尚未在年龄 <2 岁儿童中进行研究。③ 年龄≥65 岁患者中使用托珠单抗的严重感染率高于 <65 岁的患者。由于老年人群的感染率一般较高，治疗时应慎重[54]。

8. SOT 受者感染新冠病毒后，如何调整免疫抑制剂

推荐意见 12：对于轻型新冠病毒感染的 SOT 受者，建议维持原有的免疫抑制方案。（推荐强度 B，证据等级 3a）

对于中型新冠病毒感染的 SOT 受者，建议减少或停用霉酚酸（mycophenolic acids）类药物，综合评估病情后个体化调整钙调磷酸酶抑制剂（calcineurin inhibitor，CNI）或雷帕霉素靶蛋白（mammalian target of rapamycin，mTOR）抑制剂方案。（推荐强度 B，证据等级 2b）

对于重型或危重型新冠病毒感染的 SOT 受者，应停用所有非激素类免疫抑制剂。（推荐强度 D，证据等级 5）

SOT 受者长期服用免疫抑制剂，主要包括以他克莫司和环孢素为代表的 CNI 类药物，以及霉酚酸类、mTOR 抑制剂类和糖皮质激素类药物。这为新冠病毒感染治疗带来了挑战。如何维持抗感染与抗排斥反应之间的免疫平衡是改善 SOT 受者感染新冠病毒预后的关键。研究发现，在感染新冠病毒的 SOT 受者中，减少或维持基线免疫抑制对病死率没有显著影响。而且，发生新冠病毒感染后，使用他克莫司的 SOT 受者的生存率高于未使用他克莫司的受者[55-58]。另外，霉酚酸类药物的使用则与新冠病毒感染重型或危重型的发生有关，减少或停用霉酚酸类药物有助于预防重型的发生[59-60]。因此，对于轻型新冠病毒感染的 SOT 受者，建议维持原有的免疫抑制方案；对于中型新冠病毒感染的 SOT 受者，建议优先减少或停用霉酚酸类药物，而 CNI 和 mTOR 抑制剂类药物则可根据受者病情进行个体化调整；对于已经发展为重型或危重型的 SOT 受者，建议完全停用非激素类免疫抑制剂，综合评估移植物功能和新冠病毒感染情况，进行个体化治疗。

9. 如何调整抗新冠病毒药物或免疫治疗和免疫抑制剂的关系

推荐意见 13：在使用奈玛特韦/利托那韦或先诺特韦/利托那韦时应注意其与免疫抑制剂的相互作用，注意调整 CNI、mTOR 抑制剂和糖皮质激素的剂量，密切监测药物浓度。（推荐强度 B 至 C，证据等级 2c 至 4）

在使用莫诺拉韦、阿兹夫定、氢溴酸氘瑞米德韦、巴瑞替尼或托珠单抗时，初始无需调整免疫抑制剂剂量，但仍应加强药物浓度监测，同时不建议巴瑞替尼或托珠单抗与巴利昔单抗联用，警惕增加免疫抑制风险。（推荐强度 D，证据等级 5）

抗病毒药物与免疫抑制剂的相互作用汇总见表 2[61-70]。

10. 如何调整抗新冠病毒药物或免疫治疗与抗菌治疗的关系

推荐意见 14：在使用奈玛特韦/利托那韦、先诺特韦/利托那韦和阿兹夫定时，应注意其与抗菌药物的相互作用，注意药物联合使用的禁忌。（推荐强度 B 至 C，证据等级 2c 至 4）

在使用莫诺拉韦、氢溴酸氘瑞米德韦、巴瑞替尼或托珠单抗时，初始无需调整抗菌药物剂量，但仍应加强药物浓度监测。（推荐强度 D，证据等级 5）

抗病毒药物与 SOT 继发感染时常用抗菌药物的相互作用见表 3。

表 2　抗病毒药物与免疫抑制剂的相互作用

抗病毒药物	免疫抑制剂	药物相互作用原理及剂量调整方案
奈玛特韦/利托那韦(paxlovid)	他克莫司	合用可显著增加他克莫司血药浓度 在奈玛特韦/利托那韦治疗的第 1 天，给予他克莫司常规日剂量的 1/8，然后停止；第 6 天给予 1/2 日剂量；第 7 天给予 3/4 日剂量；第 8 天重启常规日剂量 注意事项：在治疗期间的第 3 天监测他克莫司浓度，并评估患者免疫状态
	环孢素	合用可显著增加环孢素血药浓度 在奈玛特韦/利托那韦治疗期间，每日给予环孢素常规日剂量的 1/5；第 6 天给予 1/2 日剂量；第 7 天给予 3/4 日剂量；第 8 天重启常规日剂量
	霉酚酸	无显著药物相互作用，无需调整剂量
	mTOR 抑制剂	联合给药可增加 mTOR 抑制剂血药浓度 在使用奈玛特韦/利托那韦前 12 h 停用 mTOR 抑制剂。奈玛特韦/利托那韦治疗结束后第 2 天 mTOR 抑制剂以原始剂量的 20% 重新使用，每日增加 20%，并根据检测的 mTOR 抑制剂血药谷浓度调整剂量
	糖皮质激素	合用可能会增加糖皮质激素的暴露量，但相互作用弱，可以不调整糖皮质激素的剂量
先诺特韦/利托那韦	免疫抑制剂	药物相互作用数据尚缺，但先诺特韦作用机制与奈玛特韦相似，可以参考奈玛特韦/利托那韦调整药物剂量
阿兹夫定	免疫抑制剂	无显著药物相互作用，无需调整剂量，但需监测药物浓度
莫诺拉韦	免疫抑制剂	无显著药物相互作用，无需调整剂量
氢溴酸氘瑞米德韦	免疫抑制剂	无显著药物相互作用，无需调整剂量

注：mTOR 为雷帕霉素靶蛋白

表 3　抗病毒药物与实体器官移植继发感染时常用抗菌药物的相互作用

抗病毒药物	与抗菌药物相互作用	常用抗菌药物种类
奈玛特韦/利托那韦	禁忌联合使用	利福平、利福喷丁
	谨慎联合使用	克拉霉素(部分大环内酯类)、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、艾沙康唑、氟康唑、索磷布韦/维帕他韦、贝达喹啉、利福布汀
	弱相互作用	克林霉素
	无相互作用	青霉素类、头孢菌素、舒巴坦、他唑巴坦、阿维巴坦、碳青霉烯类、氨基糖苷类、喹诺酮类、黏菌素类、利奈唑胺、康替唑胺、万古霉素、达托霉素、磺胺类、甲硝唑、磷霉素、呋喃妥因、多西环素(四环素类)、阿奇霉素、异烟肼、吡嗪酰胺、两性霉素 B、棘白菌素类、氟胞嘧啶、替诺福韦
先诺特韦/利托那韦	联合使用	与抗菌药物相互作用的数据尚缺，但先诺特韦作用机制与奈玛特韦相似，可以参考奈玛特韦/利托那韦选择可以配伍使用的药物
阿兹夫定	谨慎联合使用	P-糖蛋白抑制剂(如伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑、克拉霉素等)、P-糖蛋白诱导剂(如利福平等)
莫诺拉韦	无相互作用	无需调整剂量
氢溴酸氘瑞米德韦	无相互作用	无需调整剂量

11. SOT 受者选择应用抗凝药物的时机和方案

推荐意见 15：对于重型或危重型高危人群、病情进展较快的中型病例，以及重型或危重型病例，无禁忌情况下推荐预防剂量低分子肝素或者普通肝素进行预防性抗凝；治疗性抗凝适用于确诊血栓形成的患者。如使用利伐沙班等其他抗凝方案，应注意抗凝药物与抗新冠病毒药物的相互作用。(推荐强度 B，证据等级 2a)

由于新冠病毒感染后，血栓形成和肺栓塞风险显著增加[71-75]。在 50% 以上患者中发现凝血相关实验室检查指标异常，表明由于强烈的炎症反应而存在形成血栓的风险[76-77]。出现肺栓塞、深静脉血栓和(或)微血管栓塞并伴有后续器官功能障碍的比例也较高[78-80]。早期针对血栓进行预防可以显著降低住院患者的病死率[81]。目前建议对所有住院的新冠病毒感染患者使用预防剂量低分子肝素或者普通肝素进行预防性抗凝治疗，无论其是否有血栓形成或栓塞病史。治疗性抗凝治疗适用于确诊有血栓形成或在 ICU 治疗的患者[82-83]。如有低分子肝素或者普通肝素使用禁忌证，可考虑其他抗凝方案，但应注意抗凝药物与抗病毒药物的相互作用。奈玛特韦/利托那韦或先诺特韦/利托那韦有可能影响许多抗凝剂的选择和剂量，如维生素 K 拮抗剂、阿哌沙班和贝曲沙班可能都需要调整剂量，而依度沙班和利伐沙班不应与奈玛特韦/利托那韦联合给药。托珠单抗可增加 CYP3A4 的表达，但目前不建议在同时使用托珠单抗的情况下调整抗凝药物剂量[84]。

12. 中和抗体如何用于 SOT 受者感染新冠病毒的治疗

推荐意见 16：可使用没有出现免疫逃逸的中和抗体药物，联合小分子抗病毒药物对具有较高风险因素的感染新冠病毒的 SOT 受者进行治疗。(推荐强度 A，证据等级 1a)

中和抗体药物具有特异性好、安全性高、作用机制明确、便于大规模生产、能够同时用于预防和治疗等优点，成为研发抗新冠病毒药物的新突破口。如安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液可联合用于治疗轻、中型且伴有进展为重型高风险因素的成人和青少年（年龄为 12～17 岁，体质量≥40 kg）患者[26]。其Ⅲ期临床试验结果显示，与安慰剂相比，安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法使临床进展高风险的新冠病毒感染门诊患者住院和死亡风险降低 80%（$P<0.05$）；从研究第 0 天至第 28 天，治疗组没有患者死亡，而安慰剂组有 9 例患者死亡；与安慰剂组相比，治疗组患者死亡比例显著降低（$P=0.003\ 7$）；受试者无论从症状出现后的早期（0～5 d）还是晚期（6～10 d）开始治疗，都观察到类似的有效性[85]。此外，近期发表的针对安巴韦单抗/罗米司韦单抗应用于新冠病毒感染住院患者的研究结果显示，安巴韦单抗/罗米司韦单抗不能改善总体新冠病毒感染住院患者的临床预后；但进一步的亚组分析结果显示，在 513 例患者中，301 例（59%）患者血浆中新冠病毒内源性抗体呈阴性，而安巴韦单抗/罗米司韦单抗对该类患者的临床预后有潜在的益处，提示处于免疫抑制状态的 SOT 受者，其感染新冠病毒后越早进行中和抗体治疗，获益可能越大[86]。

此外，病毒变异出现了多种变异株，由于发生免疫逃逸，不同变异株对各中和抗体的敏感性也不同，所以应使用未发生免疫逃逸、敏感性高的中和抗体药物进行治疗。

除中和抗体以外，康复期血浆及新冠病毒感染人 Ig 也可考虑用于治疗新冠病毒感染[26]。但多项关于新冠病毒感染患者恢复期血浆治疗非住院患者的疗效研究结果相互矛盾，这些试验也很少纳入免疫缺陷患者。目前没有足够的证据支持或反对在免疫缺陷非住院患者中使用高效价恢复期血浆。但是异体血浆存在多种蛋白质成分，可能增加 SOT 受者发生排斥反应的风险，需要谨慎使用。

13. SOT 受者感染新冠病毒后应如何选择氧气支持方案？何时应进行俯卧位通气

推荐意见 17：感染新冠病毒的 SOT 受者的呼吸支持策略与普通肺部感染患者基本类似。根据患者的病情，可以选择普通氧疗（鼻导管、普通面罩、文丘里面罩或非重复呼吸储氧面罩等）、经鼻高流量氧疗、无创正压通气、有创正压通气和 ECMO。氧疗目标：① 无高碳酸血症风险患者，脉搏血氧饱和度（pulse oxygen saturation，SpO_2）为 92%～96%；② 高碳酸血症高风险患者，SpO_2 为 88%～92%。（推荐强度 B，证据等级 2b）

具有重症化危险因素、病情进展较快的中型、重型和危重型病例，应当早期给予规范的俯卧位通气治疗，建议每日不少于 12 h。（推荐强度 B，证据等级 2b）

急性低氧性呼吸衰竭是新冠病毒感染常见的并发症，与患者不良预后密切相关。氧疗支持对于重型或危重型新冠病毒感染的救治至关重要。感染新冠病毒的 SOT 受者，其呼吸支持策略与普通肺部感染患者基本类似。根据患者的病情，可以选择普通氧疗（鼻导管、普通面罩、文丘里面罩或非重复呼吸储氧面罩等）、经鼻高流量氧疗、无创正压通气、有创正压通气和 ECMO。氧疗目标：① 无高碳酸血症风险患者，SpO_2 为 92%～96%；② 高碳酸血症高风险患者，SpO_2 为 88%～92%[87-88]。

新冠病毒感染患者低氧性呼吸衰竭发生重要机制之一为通气/血流比例失调，因此，在部分患者中，俯卧位可能会在血流再分配和改善氧合方面提供一些暂时的优势[3-4]。研究表明，俯卧位可以降低非插管新冠病毒感染患者的呼吸频率，改善氧合[5]。俯卧位通气可以降低新冠病毒感染导致的中度至重度呼吸窘迫综合征患者的病死率[6]。因此，建议具有重症化危险因素、病情进展较快的中型、重型和危重型病例应当早期给予规范的俯卧位通气治疗，建议每日不少于 12 h[26]。

四、SOT 受者感染新冠病毒后的出院指导及预防

1. SOT 受者应何时接种疫苗？

推荐意见 18：推荐 SOT 等待者在移植前 2 周完成全程新冠病毒疫苗接种。推荐 SOT 手术 4 周后可酌情接受除了减毒活疫苗以外的新冠病毒疫苗接种。（推荐强度 D，证据等级 5）

若 SOT 受者接受 T 细胞或 B 细胞消除治疗（如使用抗胸腺细胞球蛋白或利妥昔单抗），结束治疗 12 周后可接受新冠病毒疫苗接种。（推荐强度 D，证据等级 5）

SOT 受者接种新冠病毒疫苗，可降低其感染新冠病毒后重症化的风险。（推荐强度 C，证据等级 4）

虽然目前评估新冠病毒疫苗安全性和有效性的临床试验均排除了严重免疫功能低下的患者，但由于当前授权或批准的新冠病毒疫苗都是非活性疫苗，所以理论上免疫功能低下人群也可以安全地接种新冠病毒疫苗[89-90]。鉴于新冠病毒疫苗在普通人群中的有效性，而且 SOT 受者和细胞免疫治疗接受者感染新冠病毒后出现严重不良预后的风险可能增加，因此建议对 SOT 等待者及免疫抑制治疗患者

接种新冠病毒疫苗[90-91]。然而,研究发现 SOT 受者在接种 1 或 2 剂新冠病毒疫苗后免疫抗体应答率较一般人群降低,因此可能需要额外剂次疫苗保护[9]。WHO 建议,应向中度或重度免疫力低下者提供额外剂次的疫苗[92]。SOT 受者接种新冠病毒疫苗的禁忌证同一般人群,详见《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》[93]。

SOT 等待者和受者接种新冠病毒疫苗后仍需继续采取防护措施,包括在公共场所保持社交距离、注意手卫生和避免室内人群聚集等。

2. 中和抗体如何用于 SOT 受者感染新冠病毒的预防

推荐意见 19:可使用没有出现免疫逃逸的中和抗体药物,在区域疫情流行时,对暴露后的 SOT 受者进行新冠病毒感染的预防。(推荐强度 A,证据等级 1a)

对接受 B 细胞耗竭剂治疗的 SOT 受者,可适当予以暴露前中和抗体预防。(推荐强度 B,证据等级 3a)

诸多临床研究发现,新冠病毒中和抗体不仅可以用于治疗轻型和中型且伴有进展为重型高风险因素的新冠病毒感染患者,而且在新冠病毒暴露后预防和暴露前预防中亦能发挥重要作用。尤其对于存在免疫抑制的 SOT 受者,可考虑采取额外的预防策略,如使用中和抗体。

暴露后预防是指 SOT 受者曾与新冠病毒感染患者有过接触,可以是接触过比较熟悉的密切接触者等,即使接种过疫苗,也仍然存在突破性感染的风险。暴露前预防是因为有一小部分人群由于各种原因不能接种疫苗,或者接种疫苗之后不能产生足够的免疫应答。2021 年 1 月新冠病毒中和抗体巴尼韦单抗(bamlanivimab)暴露后预防的研究数据结果显示,与安慰剂组患者相比,使用巴尼韦单抗的受试者出现有症状新冠病毒感染的风险降低 57%[94]。

2021 年 8 月替沙格韦单抗(tixagevimab)/西加韦单抗(cilgavimab)的 PROVENT Ⅲ期暴露前预防临床试验数据显示,与安慰剂组患者相比,接受替沙格韦单抗/西加韦单抗治疗者出现新冠病毒感染症状的风险降低 76.7%,中位 6 个月随访时出现新冠病毒感染症状的风险降低 82.8%,病毒防护效果持续至少 6 个月[95]。该药已在中国香港特别行政区获得有条件批准,海南省博鳌镇也通过特殊进口审批,对于 2022 年 12 月国内流行的奥密克戎 BA.5 变异株尚具有部分活性。有研究对继发性免疫缺陷人群新冠病毒感染住院和死亡风险进行单因素分析,结果显示中和抗体替代治疗作为保护因素,可降低其住院和死亡风险[96]。此外,有研究表明,对于接受 B 细胞耗竭剂及疫苗接种的免疫介导的炎症性疾病患者,暴露前预防使用替沙格韦单抗/西加韦单抗联合积极的新冠病毒感染门诊治疗可能有效地减轻这一高度脆弱人群的疾病严重程度[97]。故对于接受 B 细胞耗竭剂治疗的 SOT 受者,可适当予以暴露前中和抗体预防。

3. 感染新冠病毒后多久可以行 SOT?

推荐意见 20:对于新冠病毒感染患者,不建议进行非抢救性 SOT。对于抢救性 SOT,需经过多学科讨论权衡利弊后决定。(推荐强度 D,证据等级 5)

目前对感染新冠病毒后多久可以进行 SOT 没有明确界定,需要根据等待移植受者的病情及移植器官的类型具体分析。英国不推荐在新冠病毒感染康复期进行 SOT[98]。然而新冠病毒感染后的康复时间依据感染者的情况存在较大变化。有研究指出新冠病毒感染患者清除病毒的时间为 8~37 d,中位时间为 20 d。对于已经接受 SOT 的受者,清除新冠病毒则需要 3~5 周[10]。目前普遍认为,等待移植时间长于清除病毒时间可能获益率更大。因此,对于非抢救性的 SOT,若受者病情相对稳定,可以考虑新冠病毒核酸转阴后进行。例如,英国认为等待肾移植的新冠病毒核酸阳性患者不宜留在肾移植等待名单中,如果等待者至少 28 d 无感染症状且复查核酸阴性,可以考虑重新返回器官移植等待名单[99]。加拿大移植协会也建议在移植手术之前至少有 2 次间隔 24 h 以上的阴性核酸结果[98]。还有研究依据不同的新冠病毒感染临床分型推荐了不同的移植时机。如对于轻型患者,建议确诊新冠病毒感染后间隔 4 周再进行肾移植手术;对于中型患者,时间则为 6 周;如果患者合并基础疾病(如糖尿病、低免疫状态等)或需住院治疗新冠病毒感染,接受手术的时间应延长至 10 周;重型或 ICU 住院治疗的新冠病毒感染患者,时间可达 12 周[100]。对于等待肝移植的新冠病毒感染患者,一般建议至少感染后间隔 4 周再考虑移植,而轻型患者若 2 周后 2 次间隔 24 h 以上的核酸阴性、胸部 CT 检查无异常征象、症状消失、无并发症则可考虑肝移植[101]。

总之,对于新冠病毒感染患者,不建议进行非抢救性 SOT。而对于那些需要抢救性 SOT 的新冠病毒感染患者,因涉及因素过多,临床情况复杂多变,需要组织多学科专家讨论,权衡利弊后再决定是否进行移植手术[100,102]。

4. SOT 受者感染新冠病毒后的出院指导和随访

推荐意见 21：出院指导和随访基本同移植术后，需补充新冠病毒防护的相关内容。推荐在移植科医师指导下进行规律随访。（推荐强度 A，证据等级 1b）

感染新冠病毒的 SOT 受者依然遵循移植后的随访要求，这里不再赘述。不同的是，增加了新冠病毒相关的内容。由于 SOT 受者的情况特殊，容易合并其他疾病，且症状可能不典型，所以应教育其出院后加强自我防护和居家健康监测。自我防护包括适当的社交距离、咳嗽礼仪、清洁消毒和口罩的应用等[103]。在健康监测过程中，如有发热、咳嗽、移植器官功能不全等异常情况应及时就医[99]。除外门急诊面诊外，还可选择远程医疗作为补充，如通过电话、视频、看诊应用程序等途径积极与移植科医师联系，在移植科医师的指导下进行规律随访[102,104-105]，另外也要关注 SOT 受者出院后的心理指导。因其可能产生对自身健康状况的担忧，出现各种心理问题，移植科医师应及时提供心理疏导。需要注意的是感染过新冠病毒的 SOT 受者，如再次出现症状，且新冠病毒核酸检测再次阳性（Ct 值≤30），可在专科医师的指导下再次抗新冠病毒治疗，尽快使新冠病毒核酸转阴。

撰写组

指导委员会：张文宏（复旦大学附属华山医院感染科）、薛武军（西安交通大学第一附属医院肾移植科）、王正昕（复旦大学附属华山医院普外科）、郑建铭（复旦大学附属华山医院感染科）、陈静瑜（无锡市人民医院胸外科）、郑哲（中国医学科学院阜外医院心血管外科）、霍枫（中国器官移植发展基金会器官移植受者健康管理专项基金管理委员会）

秘书组（按姓氏拼音排序）：艾静文（复旦大学附属华山医院感染科）、陈文慧（中日友好医院呼吸与危重症医学科）、顾言阁（复旦大学附属华山医院普外科）、何玮乔（复旦大学附属华山医院普外科），胡小莹（中国医学科学院阜外医院心血管内科）、姜盛然（复旦大学附属华山医院普外科）、李力（复旦大学附属华山医院普外科）、刘甜甜（复旦大学附属华山医院感染科）、刘尊伟（西安交通大学第一附属医院肾移植科）

证据评价组（按姓氏拼音排序）：艾静文（复旦大学附属华山医院感染科）、陈文慧（中日友好医院呼吸与危重症医学科）、顾言阁（复旦大学附属华山医院普外科）、何玮乔（复旦大学附属华山医院普外科）、胡小莹（中国医学科学院阜外医院心血管内科）、姜盛然（复旦大学附属华山医院普外科）、李辉（中日友好医院呼吸与危重症医学科，国家呼吸医学中心）、李力（复旦大学附属华山医院普外科）、刘甜甜（复旦大学附属华山医院感染科）、刘尊伟（西安交通大学第一附属医院肾移植科）、马恩斯（复旦大学附属华山医院普外科）、牛万洁（复旦大学附属华山医院药剂科）、孙超（复旦大学附属华山医院普外科）、汪静怡（复旦大学附属华山医院药剂科）、王琲（复旦大学附属华山医院药剂科）、王森（复旦大学附属华山医院感染科）、于金洋（复旦大学附属华山医院普外科）、张法丽（复旦大学附属华山医院药剂科）、周晛（复旦大学附属华山医院感染科）、朱宁骐（复旦大学附属华山医院普外科）

共识专家组和外审组（按姓氏拼音排序）：蔡明（浙江大学医学院附属第二医院泌尿外科）、曹玮（中国医学科学院北京协和医院感染科）、陈静瑜（无锡市人民医院胸外科）、陈知水（华中科技大学同济医学院附属同济医院器官移植研究所）、丁小明（西安交通大学第一附属医院肾移植科）、丁洋（中国医科大学附属盛京医院感染科）、傅志仁（上海交通大学医学院附属瑞金医院普外科）、高海女（浙江树人大学树兰国际医学院附属树兰杭州医院感染科）、耿嘉蔚（云南省第一人民医院感染科）、郭文治（郑州大学第一附属医院肝胆外科）、何晓顺（中山大学附属第一医院器官移植科）、何英利（西安交通大学第一附属医院肝病内科）、黄洁（中国医学科学院阜外医院心血管内科）、霍枫（中国器官移植发展基金会器官移植受者健康管理专项基金管理委员会）、巨春蓉（广州医科大学附属第一医院呼吸内科）、李波（四川大学华西医院肝胆胰外科）、吕国悦（吉林大学第一医院肝胆外科）、门同义（山东第一医科大学第一附属医院泌尿外科）、彭劼（南方医科大学南方医院感染科）、齐海智（中南大学湘雅二医院普外器官移植科）、邱晓燕（复旦大学附属华山医院药剂科）、孙煦勇（广西医科大学第二附属医院移植医学中心）、田野（首都医科大学附属北京友谊医院泌尿外科）、王正昕（复旦大学附属华山医院普外科）、武小桐（山西省第二人民医院肾移植透析中心）、徐骁（浙江大学医学院附属第一医院肝胆胰外科）、杨扬（中山大学附属第三医院肝胆外科）、张水军（郑州大学第一附属医院肝胆胰外科）、郑建铭（复旦大学附属华山医院感染科）、郑昕（华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科）、郑哲（中国医学科学院阜外医院心血管外科）、周江桥（武汉大学人民医院器官移植科）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] World Health Organization. WHO expert committee on specifications for pharmaceutical preparations[J]. World Health Organ Tech Rep Ser, 2014(986):1-387, back cover.

[2] 蒋朱明，詹思延，贾晓巍，等. 制订/修订《临床诊疗指南》的基本方法及程序[J]. 中华医学杂志，2016，96(4)：250-253. DOI：10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.04.004.

[3] Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Ⅱ: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care[J]. CMAJ, 2010, 182(18): E839-E842. DOI: 10.1503/cmaj.090449.

[4] Chen Y, Yang K, Marušic A, et al. A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement[J]. Ann Intern Med, 2017, 166(2):128-132. DOI: 10.7326/M16-1565.

[5] Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM). Oxford Centre for Evidence-Based Medicine: levels of evidence (March 2009)[EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/oxford-centre-for-evidence-based-medicine-levels-of-evidence-march-2009.

[6] Liu H, He X, Wang Y, et al. Management of COVID-19 in patients after liver transplantation: Beijing working party for liver transplantation[J]. Hepatol Int, 2020, 14(4):432-436. DOI: 10.1007/s12072-020-10043-z.

[7] Fraser J, Mousley J, Testro A, et al. Clinical presentation, treatment, and mortality rate in liver transplant recipients with coronavirus disease 2019: a systematic review and quantitative

analysis[J]. Transplant Proc, 2020, 52(9):2676-2683. DOI: 10.1016/j.transproceed.2020.07.012.

[8] Wong GL, Wong VW, Thompson A, et al. Management of patients with liver derangement during the COVID-19 pandemic: an Asia-Pacific position statement[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2020, 5(8):776-787. DOI: 10.1016/S2468-1253(20)30190-4.

[9] Ma E, Ai J, Zhang Y, et al. Omicron infections profile and vaccination status among 1 881 liver transplant recipients: a multi-centre retrospective cohort[J]. Emerg Microbes Infect, 2022, 11(1): 2636-2644. DOI: 10.1080/22221751.2022.2136535.

[10] Raja MA, Mendoza MA, Villavicencio A, et al. COVID-19 in solid organ transplant recipients: a systematic review and meta-analysis of current literature[J]. Transplant Rev(Orlando), 2021, 35(1):100588. DOI:10.1016/j.trre.2020.100588.

[11] Jayant K, Reccia I, Virdis F, et al. COVID-19 in hospitalized liver transplant recipients: an early systematic review and meta-analysis[J]. Clin Transplant, 2021, 35(4): e14246. DOI: 10.1111/ctr.14246.

[12] Duarsa G, Sugianto R, Yusari I, et al. Predictor factor for worse outcomes in kidney transplant recipients infected with coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis[J]. Transpl Immunol, 2023, 76:101739. DOI: 10.1016/j.trim.2022.101739.

[13] Kulkarni AV, Tevethia HV, Premkumar M, et al. Impact of COVID-19 on liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis[J]. EClinicalMedicine, 2021, 38:101025. DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.101025.

[14] Bansal A, Kumar A, Bansal RM, et al. The impact of comorbidities on clinical course and outcome, in kidney transplant recipients with COVID-19: a systematic review and analysis[J]. Indian J Transplant, 2020, 14(4):275. DOI:10.4103/ijot.ijot_79_20.

[15] Bartelt L, van Duin D. An overview of COVID-19 in solid organ transplantation[J]. Clin Microbiol Infect, 2022, 28(6):779-784. DOI: 10.1016/j.cmi.2022.02.005.

[16] Kremer D, Pieters TT, Verhaar MC, et al. A systematic review and meta-analysis of COVID-19 in kidney transplant recipients: lessons to be learned[J]. Am J Transplant, 2021, 21(12):3936-3945. DOI:10.1111/ajt.16742.

[17] Mahalingasivam V, Craik A, Tomlinson LA, et al. A systematic review of COVID-19 and kidney transplantation[J]. Kidney Int Rep, 2021, 6(1): 24-45. DOI: 10.1016/j.ekir.2020.10.023.

[18] An W, Wang Q, Kim TE, et al. Clinical characteristics and outcome of coronavirus disease 2019 infection in patients with solid organ transplants: a systematic review and meta-analysis[J]. J Infect Public Health, 2022, 15(3):365-372. DOI: 10.1016/j.jiph.2022.02.002.

[19] Ho QY, Sultana R, Lee TL, et al. Coronavirus disease 2019 in kidney transplant recipients: a systematic review and meta-analysis [J/OL]. Singapore Med J, 2021[2023-02-10]. http://doi.org/10.11622/smedj.2021171. [published online ahead of print October 24, 2021].

[20] Moosavi SA, Mashhadiagha A, Motazedian N, et al. COVID-19 clinical manifestations and treatment strategies among solid-organ recipients: a systematic review of cases[J]. Transpl Infect Dis, 2020, 22(6):e13427. DOI:10.1111/tid.13427.

[21] Diaz-Arocutipa C, Carvallo-Castañeda D, Luis-Ybañez O, et al. COVID-19 in heart transplant recipients during February-August 2020: a systematic review[J]. Clin Transplant, 2021, 35(9): e14390. DOI: 10.1111/ctr.14390.

[22] Morris S, Anjan S, Pallikkuth S, et al. Reinfection with SARS-CoV-2 in solid-organ transplant recipients: incidence density and convalescent immunity prior to reinfection[J]. Transpl Infect Dis, 2022, 24(3):e13827. DOI: 10.1111/tid.13827.

[23] Vitale J, Mumoli N, Clerici P, et al. Assessment of SARS-CoV-2 reinfection 1 year after primary infection in a population in Lombardy, Italy[J]. JAMA Intern Med, 2021, 181(10):1407-1408. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.2959.

[24] Medić S, Anastassopoulou C, Lozanov-Crvenković Z, et al. Risk and severity of SARS-CoV-2 reinfections during 2020-2022 in Vojvodina, Serbia: a population-level observational study[J]. Lancet Reg Health Eur, 2022, 20:100453. DOI: 10.1016/j.lanepe.2022.100453.

[25] Qureshi AI, Baskett WI, Huang W, et al. Reinfection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in patients undergoing serial laboratory testing[J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(2): 294-300. DOI: 10.1093/cid/ciab345.

[26] 国家卫生健康委办公厅,国家中医药局综合司.新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL].(2023-01-05)[2023-02-10]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a/files/460b0e7b19bd42f3bba00c1efb9b6811.pdf.

[27] World Health Organization. Public health surveillance for COVID-19: interim guidance, 22 July 2022[EB/OL].(2022-07-22)[2023-02-10]. https://apps.who.int/iris/handle/10665/360580.

[28] 国家卫生健康委办公厅.新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)[EB/OL].(2022-03-14)[2023-02-10]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/15/5679257/files/49854a49c7004f4ea9e622f3f2c568d8.pdf.

[29] Wang W, Xu Y, Gao R, et al. Detection of SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens[J]. JAMA, 2020, 323(18): 1843-1844. DOI: 10.1001/jama.2020.3786.

[30] Marjot T, Webb GJ, Barritt AS 4th, et al. COVID-19 and liver disease: mechanistic and clinical perspectives[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2021, 18(5):348-364. DOI: 10.1038/s41575-021-00426-4.

[31] Chen Z, Xu W, Ma W, et al. Clinical laboratory evaluation of COVID-19[J]. Clin Chim Acta, 2021, 519:172-182. DOI: 10.1016/j.cca.2021.04.022.

[32] Karakoyun I, Colak A, Turken M, et al. Diagnostic utility of C-reactive protein to albumin ratio as an early warning sign in hospitalized severe COVID-19 patients[J]. Int Immunopharmacol, 2021, 91:107285. DOI: 10.1016/j.intimp.2020.107285.

[33] Liu X, Yue X, Liu F, et al. Analysis of clinical features and early warning signs in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study[J]. PLoS One, 2020, 15(6):e0235459. DOI: 10.1371/journal.pone.0235459.

[34] Wang X, Che Q, Ji X, et al. Correlation between lung infection severity and clinical laboratory indicators in patients with COVID-19: a cross-sectional study based on machine learning[J]. BMC Infect

Dis, 2021, 21(1):192. DOI: 10.1186/s12879-021-05839-9.

[35] Guo J, Wang S, Xia H, et al. Cytokine signature associated with disease severity in COVID-19[J]. Front Immunol, 2021, 12: 681516. DOI: 10.3389/fimmu.2021.681516.

[36] Mitchell O, Cosar AM, Malik MU, et al. Late liver function test abnormalities post-adult liver transplantation: a review of the etiology, investigation, and management[J]. Hepatol Int, 2016, 10(1):106-114. DOI: 10.1007/s12072-015-9685-2.

[37] Wadei HM, Lee DD, Croome KP, et al. Early allograft dysfunction after liver transplantation is associated with short- and long-term kidney function impairment[J]. Am J Transplant, 2016, 16(3): 850-859. DOI: 10.1111/ajt.13527.

[38] Buchan TA, Moayedi Y, Truby LK, et al. Incidence and impact of primary graft dysfunction in adult heart transplant recipients: a systematic review and meta-analysis[J]. J Heart Lung Transplant, 2021, 40(7):642-651. DOI: 10.1016/j.healun.2021.03.015.

[39] Shah RJ, Diamond JM. Primary graft dysfunction (PGD) following lung transplantation[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2018, 39(2):148-154. DOI: 10.1055/s-0037-1615797.

[40] Bhat K A, Madi D, Bhat S, et al. Profile of secondary bacterial and fungal infections in hospitalized COVID-19 patients in a tertiary care centre[J]. Infect Drug Resist, 2022, 15:5705-5714. DOI: 10.2147/IDR.S378221.

[41] Patel P, DeCuir J, Abrams J, et al. Clinical characteristics of multisystem inflammatory syndrome in adults: a systematic review [J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(9):e2126456. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.26456.

[42] Weiss-Tessbach M, Ratzinger F, Obermueller M, et al. Biomarkers for differentiation of coronavirus disease 2019 or extracorporeal membrane oxygenation related inflammation and bacterial/fungal infections in critically ill patients: a prospective observational study [J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9:917606. DOI:10.3389/fmed.2022.917606.

[43] Nimmo A, Gardiner D, Ushiro-Lumb I, et al. The global impact of COVID-19 on solid organ transplantation: two years into a pandemic [J]. Transplantation, 2022, 106(7):1312-1329. DOI: 10.1097/TP.0000000000004151.

[44] APASL Covid-19 Task Force, Lau G, Sharma M. Clinical practice guidance for hepatology and liver transplant providers during the COVID-19 pandemic: APASL expert panel consensus recommendations[J]. Hepatol Int, 2020, 14(4):415-428. DOI: 10.1007/s12072-020-10054-w.

[45] Gandolfini I, Crespo M, Hellemans R, et al. Issues regarding COVID-19 in kidney transplantation in the ERA of the Omicron variant: a commentary by the ERA Descartes Working Group[J]. Nephrol Dial Transplant, 2022, 37(10):1824-1829. DOI: 10.1093/ndt/gfac203.

[46] Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2022, 386(15):1397-1408. DOI:10.1056/NEJMoa2118542.

[47] 阿兹夫定片说明书[EB/OL]. [2023-02-10]. https://file.wuxuwang.com/zhuce/ssypfiles/e5d36909ee1240d2e86b0c3a15e0ac29%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6.pdf.

[48] Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients[J]. N Engl J Med, 2022, 386(6):509-520. DOI: 10.1056/NEJMoa2116044.

[49] Cao Z, Gao W, Bao H, et al. VV116 versus nirmatrelvir-ritonavir for oral treatment of Covid-19[J]. N Engl J Med, 2023, 388(5): 406-417. DOI: 10.1056/NEJMoa2208822.

[50] Helleberg M, Niemann CU, Moestrup KS, et al. Persistent COVID-19 in an immunocompromised patient temporarily responsive to two courses of remdesivir therapy[J]. J Infect Dis, 2020, 222(7):1103-1107. DOI:10.1093/infdis/jiaa446.

[51] Trottier CA, Wong B, Kohli R, et al. Dual antiviral therapy for persistent coronavirus disease 2019 and associated organizing pneumonia in an immunocompromised host[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(5): 923-925. DOI: 10.1093/cid/ciac847.

[52] Martinez MA, Chen TY, Choi H, et al. Extended remdesivir infusion for persistent coronavirus disease 2019 infection[J]. Open Forum Infect Dis, 2022, 9(8): ofac382. DOI: 10.1093/ofid/ofac382.

[53] Olumiant© (baricitinib) tablets: dosing and side effects [EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.olumiant.com/dosing-side-effects.

[54] American College of Rheumatology. Tocilizumab (Actemra) [EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Treatments/Tocilizumab-Actemra.

[55] Yin S, Wang X, Song T. Tacrolimus use and COVID-19 infection in patients after solid organ transplantation[J]. Gastroenterology, 2021, 161(2):728-730.e1. DOI: 10.1053/j.gastro.2021.01.223.

[56] Kolonko A, Kuczaj AA, Musialik J, et al. Clinical insights into the role of immunosuppression in solid organ transplant recipients with COVID-19[J]. Pol Arch Intern Med, 2022, 132(2): 16139. DOI: 10.20452/pamw.16139.

[57] Belli LS, Fondevila C, Cortesi PA, et al. Protective role of tacrolimus, deleterious role of age and comorbidities in liver transplant recipients with Covid-19: results from the ELITA/ELTR multi-center European study[J]. Gastroenterology, 2021, 160(4): 1151-1163.e3. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.11.045.

[58] Karruli A, Spiezia S, Boccia F, et al. Effect of immunosuppression maintenance in solid organ transplant recipients with COVID-19: systematic review and meta-analysis[J]. Transpl Infect Dis, 2021, 23(4):e13595. DOI: 10.1111/tid.13595.

[59] Colmenero J, Rodríguez-Perálvarez M, Salcedo M, et al. Epidemiological pattern, incidence, and outcomes of COVID-19 in liver transplant patients[J]. J Hepatol, 2021, 74(1):148-155. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.07.040.

[60] Yadav DK, Adhikari VP, Ling Q, et al. Immunosuppressants in liver transplant recipients with coronavirus disease 2019: capability or catastrophe? A systematic review and meta-analysis[J]. Front Med (Lausanne), 2021, 8:756922. DOI: 10.3389/fmed.2021.756922.

[61] Lemaitre F, Budde K, Van Gelder T, et al. Therapeutic drug monitoring and dosage adjustments of immunosuppressive drugs when combined with nirmatrelvir/ritonavir in patients with COVID-19[J]. Ther Drug Monit, 2023, 45(2):191-199. DOI: 10.1097/FTD.0000000000001014.

[62] Lemaitre F, Grégoire M, Monchaud C, et al. Management of drug-drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients treated for Covid-19: guidelines from the French Society of Pharmacology and

Therapeutics (SFPT) [J]. Therapie, 2022, 77(5): 509-521. DOI: 10.1016/j.therap.2022.03.005.

[63] Lange NW, Salerno DM, Jennings DL, et al. Nirmatrelvir/ritonavir use: managing clinically significant drug-drug interactions with transplant immunosuppressants[J]. Am J Transplant, 2022, 22(7): 1925-1926. DOI: 10.1111/ajt.16955.

[64] Salerno DM, Jennings DL, Lange NW, et al. Early clinical experience with nirmatrelvir/ritonavir for the treatment of COVID-19 in solid organ transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2022, 22(8): 2083-2088. DOI: 10.1111/ajt.17027.

[65] Devresse A, Briol S, De Greef J, et al. Safety, efficacy, and relapse of nirmatrelvir-ritonavir in kidney transplant recipients infected with SARS-CoV-2[J]. Kidney Int Rep, 2022, 7(11): 2356-2363. DOI: 10.1016/j.ekir.2022.08.026.

[66] Liu Y, Liu B, Zhang Y, et al. Intestinal absorption mechanisms of 2′-deoxy-2′-β-fluoro-4′-azidocytidine, a cytidine analog for AIDS treatment, and its interaction with P-glycoprotein, multidrug resistance-associated protein 2 and breast cancer resistance protein [J]. Eur J Pharm Sci, 2017, 105: 150-158. DOI: 10.1016/j.ejps.2017.05.009.

[67] Liu Y, Wang Y, Peng Y, et al. Effects of the antiretroviral drug 2′-deoxy-2′-β-fluoro-4′-azidocytidine (FNC) on P-gp, MRP2 and BCRP expressions and functions[J]. Pharmazie, 2018, 73(9): 503-507. DOI: 10.1691/ph.2018.8555.

[68] Hirai T, Mizuta A, Sasaki T, et al. Drug-drug interaction between remdesivir and immunosuppressant agents in a kidney transplant recipient[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2022, 60(10): 439-444. DOI: 10.5414/CP204239.

[69] Nakamura J, Yanagida M, Saito K, et al. Epstein-Barr virus encephalitis in a patient with rheumatoid arthritis [J]. Mod Rheumatol Case Rep, 2022, 6(2): 160-162. DOI: 10.1093/mrcr/rxab045.

[70] Sugawara E, Matsui K, Amasaki Y. Cytomegalovirus enteritis in a patient with rheumatoid arthritis receiving baricitinib [J]. J Rheumatol, 2020, 47(12): 1835-1836. DOI: 10.3899/jrheum.191395.

[71] Bilaloglu S, Aphinyanaphongs Y, Jones S, et al. Thrombosis in hospitalized patients with COVID-19 in a New York City Health System[J]. JAMA, 2020, 324(8): 799-801. DOI: 10.1001/jama.2020.13372.

[72] Menter T, Haslbauer JD, Nienhold R, et al. Postmortem examination of COVID-19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings in lungs and other organs suggesting vascular dysfunction[J]. Histopathology, 2020, 77(2): 198-209. DOI: 10.1111/his.14134.

[73] Middeldorp S, Coppens M, van Haaps TF, et al. Incidence of venous thromboembolism in hospitalized patients with COVID-19 [J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(8): 1995-2002. DOI: 10.1111/jth.14888.

[74] Nicolai L, Leunig A, Brambs S, et al. Immunothrombotic dysregulation in COVID-19 pneumonia is associated with respiratory failure and coagulopathy[J]. Circulation, 2020, 142(12): 1176-1189. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048488.

[75] Wichmann D, Sperhake JP, Lütgehetmann M, et al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with COVID-19: a prospective cohort study[J]. Ann Intern Med, 2020, 173(4): 268-277. DOI: 10.7326/M20-2003.

[76] Berlin DA, Gulick RM, Martinez FJ. Severe Covid-19[J]. N Engl J Med, 2020, 383(25): 2451-2460. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575.

[77] Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study[J]. Lancet, 2020, 395(10229): 1054-1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3.

[78] Cui S, Chen S, Li X, et al. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia[J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(6): 1421-1424. DOI: 10.1111/jth.14830.

[79] Klok FA, Kruip M, van der Meer N, et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19 [J]. Thromb Res, 2020, 191: 145-147. DOI: 10.1016/j.thromres.2020.04.013.

[80] Lodigiani C, Iapichino G, Carenzo L, et al. Venous and arterial thromboembolic complications in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy[J]. Thromb Res, 2020, 191: 9-14. DOI: 10.1016/j.thromres.2020.04.024.

[81] Nadkarni GN, Lala A, Bagiella E, et al. Anticoagulation, bleeding, mortality, and pathology in hospitalized patients with COVID-19[J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 76(16): 1815-1826. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.08.041.

[82] Task Force for the management of COVID-19 of the European Society of Cardiology. ESC guidance for the diagnosis and management of cardiovascular disease during the COVID-19 pandemic: part 2-care pathways, treatment, and follow-up[J]. Eur Heart J, 2022, 43(11): 1059-1103. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab697.

[83] Thachil J, Tang N, Gando S, et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19[J]. J Thromb Haemost, 2020, 18(5): 1023-1026. DOI: 10.1111/jth.14810.

[84] Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et al. COVID-19 and thrombotic or thromboembolic disease: implications for prevention, antithrombotic therapy, and follow-up: JACC State-of-the-Art review[J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 75(23): 2950-2973. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.04.031.

[85] Hoy SM. Amubarvimab/romlusevimab: first approval[J]. Drugs, 2022, 82(12): 1327-1331. DOI: 10.1007/s40265-022-01759-3.

[86] ACTIV-3/Therapeutics for Inpatients with COVID-19 (TICO) Study Group. Efficacy and safety of two neutralising monoclonal antibody therapies, sotrovimab and BRII-196 plus BRII-198, for adults hospitalised with COVID-19 (TICO): a randomised controlled trial[J]. Lancet Infect Dis, 2022, 22(5): 622-635. DOI: 10.1016/S1473-3099(21)00751-9.

[87] 中华医学会呼吸病学分会, 中国医师协会呼吸医师分会危重症医学专家组. 奥密克戎变异株所致重症新型冠状病毒感染临床救治专家推荐意见[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2023, 46(2): 101-110. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20221230-00994.

[88] Siemieniuk R, Chu DK, Kim LH, et al. Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline[J]. BMJ, 2018, 363: k4169. DOI: 10.1136/bmj.k4169.

[89] Nevermann N, Wiering L, Wu H, et al. Transplantation programs

facing lack of empirical evidence on SARS-CoV-2 vaccination: a society recommendation consensus update [J]. Transpl Infect Dis, 2021, 23(4): e13696. DOI: 10.1111/tid.13696.

[90] National Institutes of Health. Special considerations in solid organ transplant, hematopoietic cell transplant, and cellular immunotherapy candidates, donors, and recipients[EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/transplant/.

[91] American Society of Transplantation. Joint statement about COVID-19 vaccination in organ transplant candidates and recipients [EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.myast.org/joint-statement-about-covid-19-vaccination-organ-transplant-candidates-and-recipients.

[92] World Health Organization. Who needs an additional dose of COVID-19 vaccines? [EB/OL]. [2023-02-10]. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines.

[93] 国家卫生健康委员会. 新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)[EB/OL]. (2021-03-29)[2023-02-10]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/gzzcwj/202103/c2febfd04fc5498f916b1be080905771.shtml.

[94] Cohen MS, Nirula A, Mulligan MJ, et al. Effect of bamlanivimab *vs* placebo on incidence of COVID-19 among residents and staff of skilled nursing and assisted living facilities: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2021, 326(1): 46-55. DOI: 10.1001/jama.2021.8828.

[95] Levin MJ, Ustianowski A, De Wit S, et al. Intramuscular AZD7442 (tixagevimab-cilgavimab) for prevention of Covid-19 [J]. N Engl J Med, 2022, 386(23): 2188-2200. DOI: 10.1056/NEJMoa2116620.

[96] Shields AM, Burns SO, Savic S, et al. COVID-19 in patients with primary and secondary immunodeficiency: The United Kingdom experience[J]. J Allergy Clin Immunol, 2021, 147(3): 870-875. e1. DOI: 10.1016/j.jaci.2020.12.620.

[97] Calabrese C, Kirchner E, Villa-Forte A, et al. Early experience with tixagevimab/cilgavimab pre-exposure prophylaxis in patients with immune-mediated inflammatory disease undergoing B cell depleting therapy and those with inborn errors of humoral immunity [J]. RMD Open, 2022, 8(2): e002557. DOI: 10.1136/rmdopen-2022-002557.

[98] Ritschl PV, Nevermann N, Wiering L, et al. Solid organ transplantation programs facing lack of empiric evidence in the COVID-19 pandemic: a By-proxy Society Recommendation Consensus approach[J]. Am J Transplant, 2020, 20(7): 1826-1836. DOI: 10.1111/ajt.15933.

[99] National Institute for Health and Care Excellence. COVID 19 rapid guideline: renal transplantation [M/OL]. London: National Institute for Health and Care Excellence(NICE), 2020[2023-02-10]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK566060/.

[100] Kute VB, Guleria S, Bhalla AK, et al. ISOT consensus statement for the kidney transplant recipient and living donor with a previous diagnosis of COVID-19[J]. Indian J Nephrol, 2022, 32(4): 288-290. DOI: 10.4103/ijn.ijn_120_21.

[101] Kulkarni AV, Parthasarathy K, Kumar P, et al. Early liver transplantation after COVID-19 infection: the first report[J]. Am J Transplant, 2021, 21(6): 2279-2284. DOI: 10.1111/ajt.16509.

[102] Gut G, Góral A, Dal Canton Z, et al. Kidney transplantation in COVID pandemic: a review of guidelines[J]. J Clin Med, 2021, 10(13): 2877. DOI: 10.3390/jcm10132877.

[103] Mahajan S, Kohli HS, Gupta KL, et al. Infection prevention and control guidelines for COVID [J]. Indian J Nephrol, 2020, 30(3): 185-187. DOI: 10.4103/ijn.IJN_165_20.

[104] Biancone L, Minetti E, De Rosa P, et al. Telemedicine monitoring in the follow-up of kidney transplant recipients: consensus indications from an Italian panel of surgeons and nephrologists after the COVID-19 experience [J]. J Nephrol, 2022, 35(3): 725-733. DOI: 10.1007/s40620-021-01193-w.

[105] Sever MS, Vanholder R, Oniscu G, et al. Kidney transplantation during mass disasters-from COVID-19 to other catastrophes: a Consensus Statement by the DESCARTES Working Group and Ethics Committee of the ERA [J]. Nephrol Dial Transplant, 2022: gfac251. DOI: 10.1093/ndt/gfac251.

(收稿日期:2023-02-10)

(本文编辑:沈祯敏)

·读者·作者·编者·

有关文稿中法定计量单位的书写要求

具体使用参照 1991 年中华医学会编辑出版部编辑的《法定计量单位在医学上的应用》一书。注意单位名称与单位符号不可混合使用,如 ng·kg^{-1}·天$^{-1}$应改为 ng·kg^{-1}·d^{-1};组合单位中斜线和负数幂亦不可混用,如 ng/(kg·min)不宜采用 ng/kg·min^{-1}的形式。在首次出现不常用的法定计量单位处用括号加注与旧制单位的换算系数,下文再出现时只列法定计量单位。人体及动物内的压力单位使用 mmHg 或 cmH_2O,但文中首次出现时用括号加注[(1 mmHg = 0.133 kPa)或(1 cmH_2O = 0.098 kPa)]。正文中时间的表达,凡前面带有具体数据者应采用 d、h、min、s,而不用天、小时、分钟、秒。量的符号一律用斜体字母。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究